Contention physique en ESMS

Et mesures restrictives de la liberté d'aller et venir : prescrire, surveiller, tracer.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME · IEM

FICHE PRATIQUE DOTR
Mise à jour : octobre 2026

À RETENIR

La contention physique est une mesure de dernier recours : prescription médicale motivée, durée limitée — 24 h renouvelable après réévaluation (repère ANAES, non réglementaire) —, surveillance programmée, proches informés. Elle ne prévient pas les chutes.

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004 · HAS 2005

JAMAIS

Pour pallier un **manque d'effectif**, par **convenance** de l'équipe, par mesure **disciplinaire** ou **punitive** · de façon **systématique** · avec du **matériel détourné** (draps, vêtements, liens de fortune).

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004

1. Identifier la nature de la mesure

PRÉVENTION — NON RESTRICTIVE

Alternatives à la contention
Traiter une cause (douleur, hypotension, glycémie) · revoir les traitements · lit bas sans barrières · éclairage · déambulation sécurisée · activités · présence des proches · toilettes accompagnées.

Maintien postural
Corset-siège, siège moulé, sangle de positionnement : attitude corrigée, **ne se confond pas** avec la contention passive.

Retrait préventif, porte ouverte
Volontaire ou négocié, sans restriction.

Sources : ANAES 2000 · Afssaps 2006 · ANSM 2020 · HAS 2020 polyhandicap · ANESM 2016-2017

CONTENTION PHYSIQUE PASSIVE

Tout moyen, matériel ou vêtement qui **empêche ou limite la mobilisation volontaire** de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir la sécurité.

Au lit
Barrières relevées · ceinture ou sangle · couchage de contention.

Au fauteuil
Ceinture ou sangle · tablette fixée · siège gériatrique ou basculé · gilet, harnais.

Membres et vêtements
Attaches de poignets ou de chevilles · combinaison, moufles.

Sources : ANAES 2000 · ANSM 2020

LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR

Restreint les déplacements sans immobiliser le corps.

- Chambre fermée à clé, **confinement**
- Espace de calme-retrait **fermé**
- Accès contrôlé, digicode, localisation : un **pis-aller** — intervention humaine préférable

Exceptionnelle, **collégiale**, motivée, portée au dossier et au registre, **information rapide de l'entourage**. **EHPAD** : annexe au contrat de séjour.

Sources : Consensus 2004 · ANESM 2016-2017 · CASF L311-4-1

2. Le motif justifie-t-il une contention ?

MOTIF INVOQUÉ	STATUT ET CE QUE DISENT LES SOURCES
Risque de chute	Efficacité non démontrée — Aucune preuve d'efficacité ; la contention est un facteur indépendant de gravité de la chute. Ne justifie pas, à lui seul, une contention.
Déambulation, errance	Efficacité non démontrée — Sans preuve d'efficacité, pas une véritable indication médicale. Alternative : espace de déambulation sécurisé.
Agitation	Efficacité non démontrée — Sans preuve d'efficacité ; la contention peut aggraver confusion et agitation. Rechercher et traiter une cause.
Mise en danger de soi	Dernier recours possible — Envisageable en dernier recours, après appréciation du danger et échec des alternatives.
Danger pour autrui	Dernier recours possible — Envisageable en dernier recours, après appréciation du danger pour la personne et les tiers.
Protection d'un dispositif médical	Règles générales — Non détaillé par les sources consultées : règles générales — dernier recours, durée la plus courte, réévaluation.
Sortie dangereuse, risque de fugue	Liberté d'aller et venir — Liberté d'aller et venir : intervention humaine et aménagement préférables aux dispositifs électroniques ; EHPAD : annexe au contrat de séjour.
Glissement au fauteuil	Positionnement — Relève du maintien postural, pas de la contention passive.

Sources : ANAES 2000 · HAS 2005 · Consensus 2004 · HAS 2009 · ANESM 2016-2017 · CASF L311-4-1 · ANSM 2020

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique. Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

3. Prescrire

CONTENU DE LA PRESCRIPTION

Avant de prescrire

- **Danger** apprécié pour la personne et pour les tiers
- **Alternatives** tentées et tracées
- Rapport **bénéfice/risque** apprécié par l'équipe pluridisciplinaire
- Personne et proches **informés** des raisons et des buts ; consentement et participation recherchés

La prescription précise

- Écrite, horodatée, prescripteur identifié
- Motifs de la contention
- Durée prévisible / période de mise en place
- Risques à prévenir
- Programme de surveillance
- Matériel de contention

Urgence : en l'absence de médecin, prescription possible a posteriori, confirmée dans les plus brefs délais par un médecin.

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004 · ANSM 2020

DURÉES ET SURVEILLANCE — REPÈRES

Validité de la prescription

24 h, reconduite si nécessaire après réévaluation, par une prescription motivée. Couchage de contention : **12 h** à la première utilisation, puis 24 h.

Contrôle — au moins toutes les heures

Fonction respiratoire · peau aux points d'attache et d'appui · hydratation · continence.

Levée de la contention

Aussi souvent que possible — **au moins toutes les 2 h** selon certains auteurs — pour maintenir l'état fonctionnel.

Réévaluation médicale

État de santé et conséquences de la contention : **au moins toutes les 24 h**, tracée.

Soins programmés

Hygiène, nutrition, hydratation, accompagnement psychologique, activités ; intimité et dignité préservées.

Plus strict : le consensus 2004 réserve la contention à l'urgence médicale, avec réévaluation **toutes les 3 h au plus**.

Sources : ANAES 2000 · ANSM 2020 · Consensus 2004

4. Qui décide, qui informe

EHPAD

Contention : prescription médicale motivée.

Liberté d'aller et venir : annexe au contrat de séjour.

- Examen du résident, procédure **collégiale** à l'initiative du médecin coordonnateur (à défaut, du médecin traitant)
- Évaluation pluridisciplinaire bénéfices/risques, conservée au dossier médical
- Consentement recherché mesure par mesure
- Réévaluation au moins tous les **six mois**

Sources : ANAES 2000 · CASF L311-4-1

MAS · FAM · EAM

Aucun texte spécifique trouvé : l'annexe au contrat de séjour ne vise que les établissements pour personnes âgées.

S'appliquent les recommandations :

- Mesure d'exception, **dernier recours** face à un danger immédiat, levée dès que les motifs disparaissent
- Prescription médicale en temps réel
- Protocole individualisé, gestes de protection appris en formation
- **Débriefing** après toute mesure restrictive, **rapport d'incident**, instance éthique si elle existe
- Adhésion de la personne et de ses représentants recherchée

Sources : CASF L311-4-1 · ANESM 2016-2017 · Consensus 2004

IME · IEM (MINEURS)

- Titulaires de l'autorité parentale **informés**, consentement et participation recherchés
- Consentement du mineur **systématiquement recherché** s'il est apte à exprimer sa volonté
- Enfant associé aux décisions selon son âge et sa maturité
- Espaces de calme-retrait : adhésion des parents **formalisée**

Sources : ANAES 2000 · CSP L1111-4 · C. civ. 371-1 · ANESM 2016-2017

MAJEUR PROTÉGÉ

- **Mesure avec assistance** : consentement de la personne recherché, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection.
- **Représentation relative à la personne** : consentement obtenu si la personne est apte ; à défaut, autorisation de la personne chargée de la protection, qui tient compte de l'avis exprimé. Désaccord hors urgence : le juge tranche.

Sources : CSP L1111-4 · C. civ. 459

URGENCE

- Prescription possible **a posteriori**, confirmée dans les plus brefs délais par un médecin.
- **EHPAD, mesures relevant de l'annexe** : le médecin coordonnateur et le directeur prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir **à lui-même** ; ils informent **immédiatement** le protecteur ou la personne de confiance ; sans mesure de protection, **sauvegarde de justice** déclarée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur ; mesures inscrites ensuite dans l'annexe.
- Information des proches **dès que possible**, tracée.

Sources : ANAES 2000 · CASF R311-0-8 · Consensus 2004

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique. Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

5. Sécuriser le matériel

AU LIT

Barrières de lit

- Barrières non conçues pour empêcher une sortie volontaire du lit : risque de chute par-dessus et de piégeage (tête, cou, thorax, membres).
- Barrière compatible avec le lit et le matelas ; verrouillage vérifié à chaque utilisation ; revoir les dimensions en cas de sur-matelas ou de matelas thérapeutique.
- Lit en position basse en dehors des soins.
- Protège-barrières possibles pour éviter le piégeage des membres.

Ceinture au lit

- Fixation aux parties fixes, sommier ou cadre du lit, jamais au matelas ni aux barrières ; lit réglable : fixer aux parties qui bougent avec le patient.
- Maintien pelvien recommandé ; dispositif de taille adaptée à la morphologie.
- Barrières latérales entières, en position haute, compatibles avec le lit, verrouillées.
- Éviter l'attache à la tête du lit (compression axillaire) ; prévenir régurgitations et escarres en position allongée.

Couchage de contention

- Retirer immédiatement le dispositif si le patient s'agite dedans.
- Vérifier l'absence de compression ou de piégeage lors du gonflement d'un matelas à air.

Sources : Afssaps 2006 · ANSM 2020 · ANAES 2000

AU FAUTEUIL ET AUX MEMBRES

Ceinture au fauteuil

- Maintien pelvien conseillé ; sangles placées au bon endroit, serrage adapté, aucun nœud.
- Palettes repose-pieds réglées (hauteur, inclinaison, profondeur) pour éviter le glissement ; fauteuil adapté à la morphologie, résident assis au fond du siège.
- Dispositif prévu pour le fauteuil et de taille adaptée. Décès rapportés lors de tentatives d'extraction du fauteuil.

Gilet / harnais

- Risque de strangulation ou de compression thoracique en cas de glissement : maintien pelvien recommandé.
- Dispositif de taille adaptée, installé selon les consignes du fabricant, par un personnel formé.

Attaches des membres

- Matériel conforme, en bon état, adapté à la taille ; jamais de lien de fortune.
- Contrôle de l'état cutané aux points d'attache à chaque passage.

Sources : ANSM 2020 · ANAES 2000

SÉCURITÉ

La HAS rappelle aux EHPAD en 2026 : **limiter le recours à la contention physique passive** et, si elle ne peut être évitée, respecter les bonnes pratiques d'utilisation. Entre 2011 et 2019, **130 signalements** liés aux dispositifs médicaux de contention ont été déclarés à l'ANSM, dont des **décès** au fauteuil, au lit et en couchage de contention — souvent lors de tentatives d'extraction du dispositif. Un dispositif de contention n'est manipulé que par un **personnel formé**.

Sources : HAS 2026 · ANSM 2020

6. Tracer

DANS LE DOSSIER DU RÉSIDENT

- Prescription motivée dans le dossier du résident
- Surveillance programmée, mise en œuvre et retranscrite
- Registre des contentions et confinements consultable dans l'établissement
- Réévaluation tracée à chaque renouvellement
- Handicap : alternatives réalisées, information de la personne, surveillance et vérifications tracées ; débriefing après toute mesure restrictive ; rapport d'incident

Sources : ANAES 2000 · Consensus 2004 · ANESM 2016-2017

NE PAS TRANSPOSER LA PSYCHIATRIE

Les durées légales de l'isolement et de la contention en psychiatrie — **contention de 6 h renouvelable, 24 h au total** — visent les patients hospitalisés **sans consentement** en établissement autorisé en psychiatrie.

Elles **ne s'appliquent pas** aux ESMS. La recommandation HAS 2017 (psychiatrie) reste un repère éthique.

Sources : CSP L3222-5-1 · HAS 2017

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique. Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.

7. Prescrire en quelques clics : l'outil de l'Espace VMS

OUTIL « PRESCRIPTION DE CONTENTION » — RUBRIQUE CONTENTIONS

Choisir la mesure et le ou les motifs dans les menus déroulants : l'outil affiche la nature de la mesure, les alertes des sources et les consignes de sécurité du matériel. Les durées et fréquences sont préremplies avec les repères ci-dessus et **restent modifiables** ; l'échéance de la prescription est calculée.

- **PDF d'une page**, individualisé, à imprimer et signer
- **Texte structuré** (gras, souligné) à copier-coller dans le logiciel de l'établissement : Copier dans l'outil, puis coller dans l'observation médicale ou le module de prescription du dossier du résident (Cmd + V sur Mac, Ctrl + V sur PC)
- Aucune donnée n'est envoyée sur Internet : tout reste sur le poste

Sources et textes de référence

ANAES 2000 — ANAES (HAS), « Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée », octobre 2000 — référentiel en 10 critères (p. 19-20) ; outil HAS mis à jour le 25/01/2010. https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/contention.pdf

Consensus 2004 — ANAES / FHF, conférence de consensus « Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de sécurité », 24-25 novembre 2004 (texte long, p. 20-24). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/Liberte_aller_venir_long.pdf

HAS 2005 — HAS / SFDRMG, « Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée », novembre 2005 (recommandations et argumentaire, p. 16). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/prevention_des_chutes_-_argumentaire.pdf.pdf

HAS 2009 — HAS, « Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées : prise en charge des troubles du comportement perturbateurs », mai 2009 (p. 12). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2009-07/maladie_dalzheimer-troubles_du_comportement_perturbateurs-recommandations.pdf

ANSM 2020 — ANSM, rapport « Sécurisation d'un patient à l'aide d'un dispositif médical de contention mécanique ou de maintien postural », octobre 2020, et fiches de recommandations lit, fauteuil et couchage (mises à jour le 10/11/2021). https://ansm.sante.fr/actualites/recommandations-pour-assurer-la-securite-des-patients-necessitant-une-contention-medicale

Afssaps 2006 — Afssaps, « Bonne utilisation des barrières de lit » et « Pour une utilisation sécurisée des barrières de lit — Questions/Réponses », janvier 2006. https://archive.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3cbe284a28a22fcba800dad4f6728bc0.pdf

ANESM 2016-2017 — ANESM (HAS), « Les comportements-problèmes au sein des établissements et services intervenant auprès des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses », volets 1 et 2 (2016, p. 94 et 107-108 : « Les mesures d'exception »), synthèse-outils (p. 8 et 36-39) et volet 3 « Les espaces de calme-retrait et d'apaisement » (2017). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/web_anesm_synthese-outils_rbpp-2.pdf

HAS 2020 polyhandicap — HAS, recommandation « L'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité — Les dimensions fonctionnelles », 2020 (p. 25-26). https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/polyhandicap_2_dimensions_fonct.pdf

HAS 2026 — HAS, « Analyse des déclarations d'EIGS en lien avec les Ehpad », outil d'amélioration des pratiques mis en ligne le 16/09/2026. https://www.has-sante.fr/jcms/p_4126767/fr/analyse-des-declarations-d-eigs-en-lien-avec-les-etablissements-d-hebergement-pour-personnes-agees-dependantes-ehpad

CASF L311-4-1 — Code de l'action sociale et des familles, art. L311-4-1 (version en vigueur depuis le 10/04/2024), art. R311-0-5 à R311-0-9 (décret n° 2016-1743 du 15/12/2016) et annexe 3-9-1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721307

CASF R311-0-8 — Code de l'action sociale et des familles, art. R311-0-8 (mesures provisoires en cas de force majeure), version en vigueur depuis le 01/09/2018 (décret n° 2018-767 du 31/08/2018). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037362263

CSP L1111-4 — Code de la santé publique, art. L1111-4 (consentement ; mineur ; majeur protégé). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056

C. civ. 459 — Code civil, art. 459 (décisions relatives à la personne du majeur protégé), version en vigueur depuis le 25/03/2019. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310445

C. civ. 371-1 — Code civil, art. 371-1 (autorité parentale), version en vigueur depuis le 21/02/2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049164413

CSP L3222-5-1 — Code de la santé publique, art. L3222-5-1 et instruction DGOS/R4/2022/85 du 29/03/2022 : isolement et contention en psychiatrie, patients en hospitalisation complète sans consentement — dispositif propre aux établissements autorisés en psychiatrie. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048447133

HAS 2017 — HAS, « Isolement et contention en psychiatrie générale », février 2017 : champ de la psychiatrie, non applicable directement en ESMS ; repère éthique. https://www.has-sante.fr/jcms/pprd_2974270/fr/isolement-contention-pratiques-de-dernier-recours

Note : fiche de repères pour les médecins DOTR ; elle ne remplace ni le protocole de l'établissement ni l'évaluation clinique. Recommandations citées : 2000 à 2020 — aucune recommandation HAS plus récente propre à la contention en ESMS n'a été trouvée.